

Fecha Última Actualización: 14-06-2025 12:26:56

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Eugenia De Las Mercedes Moreno Acev **Rut** : 6.844.437-3 **N° Archivo** : 0704111
Edad : 69a 3m 29d **Fecha Nacto**: 16/02/1956 **Sexo** : Femenino
Dirección : Pje. Lircay 1357 Pobl. Oscar Bonilla **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 983690642

N° Epicrisis
443048

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion **Fecha Ingreso** : 02/06/2025 20:27 **Días Estadía**: 12
Unidad de Egreso : Geriatria **Fecha Egreso** : 14/06/2025 12:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Eugenia De las Mercedes Moreno
Edad: 6844437-3
RUT: 69 años
Dirección: Pje. Lircay 1357 Pobl. Oscar Bonilla
Tutor: Hijo Ricardo F: 935286904
Fecha de Ingreso a CASR: 02/06/2025
Fecha de ingreso UGA: 04/06/2025

BIOMÉDICOS

Antecedentes mórbidos: HTA, DM NIR, epilepsia temporal izq focal (último control neurología 2022), FA en taco, LCFA usuario de o2 nocturno 1 litro por 12 horas

Fármacos:

Metformina 850mg 1-0-1
Losartan 50mg 1-0-1
AAS 100mg 0-1-0
Carvedilol 25mg 1-0-1
Amlodipino 10mg 1-0-0
ATV 20mg 0-0-1
B ipatropio 2puff cada 6 hrs
TACO (Acenocumarol)
Fenitoina 100mg: 1-0-2
Furosemida ??

Cirugías: hernioplastia umbilical

Alergias: (-)

Hábitos : Tabaco: 10 años sin fumar 3 CIG diarios OH: no Drogas: no

Deposiciones: Hábito intestinal día por medio Diuresis sin alteraciones

Inmunizaciones: vacunas 2025 + influenza COVID

Fecha Epicrisis : 14/06/2025 12:26

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 14-06-2025 12:26:56

Hospitalizaciones previas: 2022 shock séptico por hernia complicada .

FUNCIONAL

Barthel: 70/100 dependencia leve, Asistencia para traslados y deambular, requiere ayuda para ponerse zapatos , no sube escaleras

Lawton: 6/8 no compra. se traslada en taxi.

Actividades avanzadas: no

Caídas el último año: No Tr.Marcha: no

Ayudas técnicas no

Audífonos: no Lentes ópticos: para leer y para ver Prótesis dental: no

COGNITIVO/MENTAL

Escolaridad: 8vo básico

Ocupación previa: manipuladora de alimentos

Quejas de memoria: no

Patología psiquiátrica previa: no

Trastorno del ánimo: no

Trastorno del sueño: sospechas de SAHOS

Historia de delirium: no

ANTECEDENTES SOCIALES

Estado civil: casada

Vive con esposo

Tiene 2 hijos , 52 años Ricardo , 45 Fabiola

Red de apoyo : hija vive en Chillán , Ricardo vive en casa de al lado

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Deterioro cognitivo no

Demencia no

Delirium no

Constipación si sin tratamiento

Incontinencia/retención urinaria no

Trastorno del peso Obesidad sarcopénica

Sarcopenia SARFC 4 puntos

Trastorno de la marcha y caídas dificultad de la marcha por disnea.

Polifarmacia si

Trastorno del ánimo no

Trastorno del sueño no

Fragilidad EVF 5

Déficit sensorial ocupa lentes

Úlceras por presión no

MOTIVO DE INGRESO: Disnea

Historia clínica:

Paciente consulta por cuadro de 2 semanas de evolución que inicia con edema de extremidades inferiores, posteriormente una semana por disnea de medianos esfuerzos evolucionando llegando al reposo, consulta inicialmente en APS en donde presenta saturación de 70% . A SU CASR ingresa poco reactiva, parcialmente orientada, taquicárdica , sinusal, afebril, normotensa con requerimientos de oxígeno mascarilla venturi Fio2 al 35% sin uso de musculatura accesoria, se escribe llene capilar lento, mottling I. Se toma AngioTAC de tórax se descarta TEP se describen ¿sugeres de hipertensión pulmonar asociado a signos de sobrecarga crónica de cavidades derechas. Leve derrame pleural bilateral. Exámenes destaca acidosis respiratoria (PH 7.1, PcO2 77) por lo que se decide conectar a VMNI se mantiene con VMNI hasta hoy 04/06 en la mañana 11:30 sin registro de cuando fue desconexión a las 15 horas descritos signos vitales con naricera de 3 litros. Se manejo con terapia depleitiva + corticoterapia endovenosa además se dejó tratamiento con ceftriaxona por orina inflamatoria. Se traslada a UGA para continuar manejo de cuadro agudo.

EX FISICO INGRESO:

CSV: PA 126/67 pam 88 FC 110 lpm 3 litros por naricera

Paciente vigil espontánea, orientada TEP. CAM (-)

yugulares no visibles a 45°

tórax simétrico sin uma. MP disminuido globalmente roncus y crepitos.++

abdomen globuloso con edema de pared + RHA + no palpo masas ni megalias sin signos de irritación peritoneal. Sonda Foley insitu

extremidades pulsos presentes simétricos edema ++

EXÁMENES

Laboratorio:

Lab 04/06: PH 7.23 PCO2 71 HCO3 29

03/06: 19:35: Ph: 7.219 PcO2: 64.1 hcO3: 25.6. INR 3.5

03/06 (14:09) GSV pH 7.178, CO2 77.0, HCO3 28.0, Na 140, K 4.63, Cl 105, alb 3.3, Bili T 0.38, Bili D 0.21, Ca 8.2, crea 1.54, PCR 18.7, Hb 12.2, Hto 40.1, leuco 7.66, plaq 179

OC: Leucos 15-20, bacterias escasas.

02/06

Ácido láctico 22.2, Ácido úrico 8.3, Amilasa 36, Bili T 0.33, Bili D <0.10, FA 88, GGT 251, GOT 29, GPT 22, Creatinina total 36, Crea 1.58, BUN 43.8, LDH 571, Lipasa 34, Magnesio 2.1, PCR 11.6, alb 3.4, Ca 7.9, Troponina I ultrasensible 52.4, Glucosa 130, Proteínas totales 6.8, TP 41.2, INR 4.75, TTPA 38.8, Na 138, K 4.92, Cl 106, GSV pH 7.196, CO2 69.9, HCO3 26.5, EBVT -1.6, Hto 43.5, Hb 12.4, leuco 7.82, plaq 190 pcr 11.6.

Imágenes:

03/06 AngioTC Tórax: Examen negativo para tromboembolismo pulmonar agudo.

Significativo aumento de calibre de arteria pulmonar, sugerente de hipertensión pulmonar asociado a signos de sobrecarga crónica de cavidades derechas.

Leve derrame pleural bilateral.

Microbiológico:

03/06: P viral (-)

UC 03/06 pendiente

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Insuficiencia Respiratoria Aguda tipo II sobre crónica

ICC descompensada + LCFA

Acidosis respiratoria

Obs ITU

AKI KDIGO I prerenal

Antecedentes: HTA, DM NIR, epilepsia temporal izq focal (último control neurología 2022), FA en taco, LCFA usuario de o2 1 litro en las noches.

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Constipación, obesidad sarcopénica, polifarmacia, fragilidad.

FUNCIONAL

·Dependencia leve ABVD Barthel 75/100

·Dependencia AIVD lawton 6/8

COGNITIVO/MENTAL

·Sin deterioro cognitivo

Fecha Última Actualización: 14-06-2025 12:26:56

Página 4 de 5

SOCIAL

Paciente con red social acotada pero efectiva, destino al alta domicilio.

En UGA evoluciona de la siguiente manera:

Hemodinamia/cardiovascular: Con hemodinamia estable, con FA con tendencia a la taquicardia con inicio reciente de BB en dosis menores a las habituales en contexto de IC descompensada, con plan de aumentar dosis según control de FC.

Sin antecedente de IC conocido, sin ecocordio en sistema, ingresa con debut de IC en patrón tibio/humedo, sin descompensante identificado, falta de tratamiento?, tiene 1 TUS de 57 tomada en SU, curva de troponinas negativas. Se mantuvo con terapia depleitiva endovenosa para objetivo de BH -1.000 a - 1.5000 con adecuada respuesta terapéutica. Actualmente traslape oral y seguimiento por UHD

Se realizó eco cardiograma que concluye: 1. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve con función sistólica global moderadamente

disminuida en presencia de fibrilación auricular.

2. Disfunción diastólica con presiones de llenado elevadas.

3. Dilatación biauricular.

4. Cambios degenerativos de válvulas mitral y aórtica, sin repercusión funcional.

5. Ventrículo derecho dilatado e hipertrófico con función sistólica global conservada.

6. Insuficiencia tricuspídea leve.

7. Hipertensión pulmonar (PSAP 65 mmHg).

FE 40%

Deja medicamentos para tratamiento de IC fevi reducida, seguimiento por cardiología ambulatorio.

Respiratorio: de LCFA usuaria de oxígeno nocturno (paciente no sabe porque ocupa oxígeno) Hospitalizada en contexto de insuficiencia respiratoria que impresiona secundaria a ICC. Tiene angioTAC que descarta TEP y describe signos de hipertensión pulmonar, sobrecarga de cavidades derechas crónicas y derrame pleural bilateral.

Usuaria de oxigenoterapia nocturna 0.5 litros por nariz 12 horas

Nefrológico: Sin antecedente de ERC última creat en sistema 0.93 (09/01/2025) actualmente ingresa con creat 1,58 (VFG CKD-EPI 39 ml/min), impresiona Sd. cardiorrenal, con buena respuesta a terapia depleitiva, seguimiento.

Infeccioso: Se inició ceftriaxona en SU en contexto de SO inflamatorio. Al ingreso con leve aumento de PCR (18), sin leucocitosis, UC negativo, sin historia de síntomas urinarios, por lo que suspendo antibiótico.

Neurológico: Antecedente de epilepsia temporal izquierda focal sin controles recientes, mantengo tratamiento farmacológico de base, al alta control con especialidad.

Endocrino: antecedente de DM2 NIR, HbA1c 8.1% - Insulina en indicaciones.

Geriatría:

- función a I: Paciente dependiente leve de ABVD, dependiente de AIVD en contexto de disnea, se mantiene en seguimiento por equipo multidisciplinario para prevención de desfuncionalización durante hospitalización.

- Cognitivo: sin alteraciones cognitivas previas según relato de paciente, CAM (-) actual

- Social: Red social presente destino de alta domicilio.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Cardíaca Descompensada - EPOC Descompensado

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

buen estado general

Plan Post Alta

Regimen común sin sal

Reposo relativo

Furosemida 40 mg 2 veces al día 07 y 19 horas por 5 días, luego iniciar espironolactona 25 mg día vo

Losartan 25 mg día vo

Bisoprolol 5 mg AM y 2.5 mg PM

Bromuro de ipratropio 2 puff cada 4 horas

Fecha Epicrisis : 14/06/2025 12:26

Página 4 de 5



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Página 5 de 5

Fecha Última Actualización: 14-06-2025 12:26:56

Acenocumarol 4 mg 1/2 comp dia dia vo todos los dias hasta control TACO
Fenitoina 100mg am - 200mg pm, via oral
Insulina nph 16 UI AM, 10 UI PM
Empagliflozina 10 mg dia hasta control con cardiologia
Seguimiento por Cardiologia
Seguimiento por broncopulmonar
Kine motora y respiratoria por UHD, TO

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Paulina Estrada Hormazabal
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 14/06/2025 12:26

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:45

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar